

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: FÉMUR

A.R. Trapote Cubillas, E. Matilla Basoa, J. Fernández Díaz.

FRACTURAS DIAFISARIAS DE FÉMUR

INTRODUCCIÓN

Son las fracturas que se producen entre la región subtrocantérea de la cadera y la región supracondílea de la rodilla. Generalmente se asocian a mecanismos de alta energía.

DIAGNÓSTICO

Es clínico y se confirma con la radiografía

Exploración física

Clínicamente se puede encontrar una deformidad en el muslo, con acortamiento, inflamación y dolor a la palpación. Se debe evaluar el estado neurovascular de la extremidad y la pérdida de sangre, ya que esta puede ser importante (hasta 1500 cc) requiriendo reposición hídrica y de hemoderivados.



Fractura diafisaria de fémur

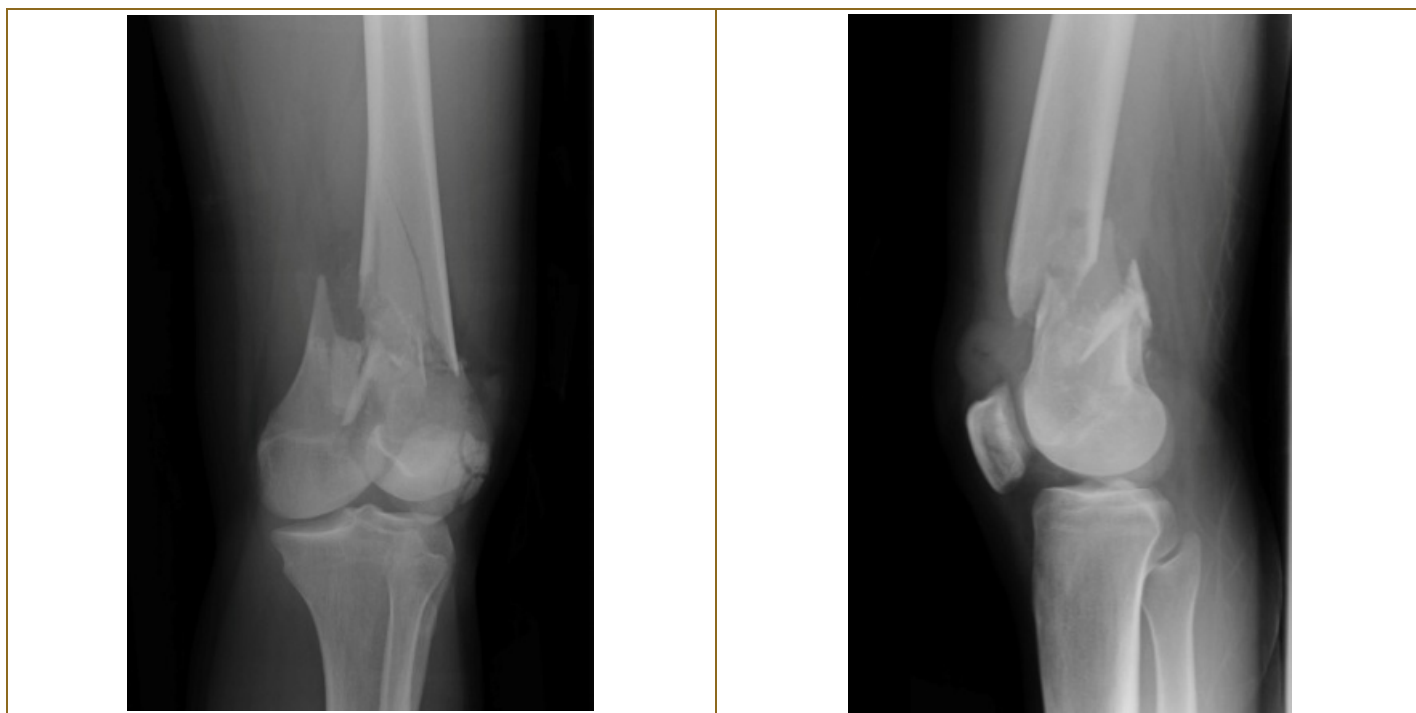
Pruebas complementarias

Radiografías anteroposterior y lateral del fémur. Además, es necesaria la búsqueda de lesiones asociadas, solicitando radiografías de pelvis y rodilla.

TRATAMIENTO

El tratamiento del dolor, así como la inmovilización mediante férula y tracción constituyen el tratamiento inicial de estas fracturas. El tratamiento definitivo es quirúrgico, por lo que requieren ingreso hospitalario.

FRACTURAS REGIÓN DISTAL DEL FÉMUR



Fractura supracondílea de fémur

INTRODUCCIÓN

Las fracturas de la región distal del fémur son las que abarcan desde los cóndilos femorales hasta la unión de la metáfisis con la diáfisis.

Según la localización se dividen en:

- Supracondíleas
- Intercondíleas
- Condíleas

Presentan una distribución bimodal, un primer grupo en pacientes jóvenes tras un mecanismo de alta energía como un accidente de tráfico o una caída desde gran altura y un segundo grupo en pacientes ancianos tras una caída con traumatismo de baja energía.

DIAGNÓSTICO

Exploración física

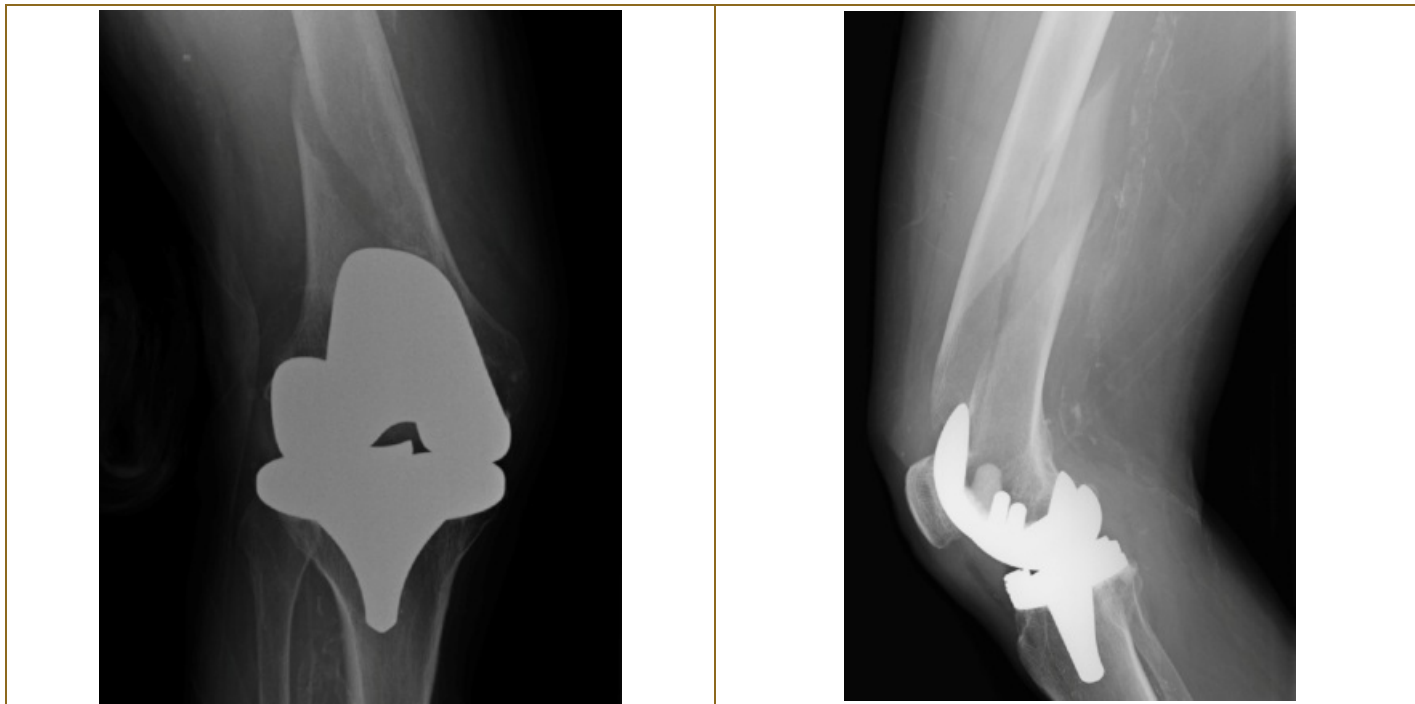
Clínicamente los pacientes presentan incapacidad para la deambulación, con tumefacción, dolor y deformidad en la región inferior del muslo y la rodilla. Es imprescindible realizar una evaluación neurovascular del miembro, ya que se puede producir afectación de la arteria poplítea.

Pruebas complementarias

Radiografía anteroposterior y lateral de la rodilla, incluyendo el fémur completo. Las fracturas intraarticulares complejas pueden requerir pruebas complementarias tales como TC.

Tratamiento:

El tratamiento inicial consiste en control del dolor e inmovilización. Generalmente el tratamiento definitivo es quirúrgico, requiriendo ingreso.



Fractura supracondílea de fémur (periprotésica)

Ante un paciente intervenido de artroplastia de rodilla con un traumatismo en dicha región que presenta dolor y edema, debemos descartar una fractura periprotésica.

BIBLIOGRAFÍA

- “Manual del residente de C.O.T.” 2014, SECOT, Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. ISBN: 978-84-697-0756-2.
- “Fundamentos. Traumatismos en Urgencias” 2012, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 978-84-15419-44-0.
- “Manual de Fracturas” 5ª Edición, 2016, Wolters Kluwer. ISBN: 978-84-16004-82-9.